

Mid-Urethral Sling (para sa Stress Incontinence)

WARWIKI

Impormasyon para sa Pasyente · Mabilis at epektibong operasyon para sa pagtagas ng ihi

Ang mid-urethral sling ang pinaka-karaniwang operasyon para sa **stress urinary incontinence (pagtagas ng ihi kapag may diin)** sa kababaihan — pagtagas kapag umubo, tumawa, nagbuhat, o nag-ehersisyo. Isang manipis na strip ng malambot na mesh ang inilalagay sa ilalim ng gitna ng urethra para suportahan ito, upang manatiling sarado kapag may puwersa. Mabilis ito, kadalasang outpatient, at lubhang epektibo at pangmatagalan.

Tungkol sa Prosedurang Ito

Sa pamamagitan ng maliit na hiwa sa loob ng puki (vagina), isang manipis na tape ang inilalagay nang **walang tensyon** sa ilalim ng gitna ng urethra tulad ng isang hamaka. Kapag umubos o nagpumilit, ang urethra ay natatambok sa sling at nananatiling sarado. **Wala nang kailangang gawin** pagkatapos — gumagana ito nang kusa. May iba't ibang ruta (retropubic at transobturator) at single-incision na “mini” sling; pipiliin ng inyong siruhano ang pinaka-angkop para sa inyo.

Tungkol sa Mesh

Ang synthetic mid-urethral sling ay isa sa mga **pinaka-pinag-aralan** na pamamaraan sa kalusugan ng kababaihan, na may matibay na katibayan sa pangmatagalang kaligtasan at tagumpay. Ito ay **kaiba** sa transvaginal mesh para sa prolapse (pagbaba ng organ) na nagbigay ng babala ang FDA. Kung mas gusto ninyong iwasan ang synthetic mesh, ang sling mula sa **inyong sariling tissue** (autologous fascial sling) ay isang alternatibo.

MGA TERMINO

Stress incontinence

Pagtagas ng ihi kapag may diin — pag-ubo, pagtawa, pagbubuhat.

Mid-urethral sling

Isang mesh tape na sumusuporta sa gitna ng urethra.

Tension-free

Ang sling ay nasa ilalim ng urethra nang hindi ito pinipiga.

Retropubic / transobturator

Dalawang ruta ng sling; parehong epektibo.

Autologous sling

Sling mula sa sariling tissue, hindi mesh.

Mesh exposure

Bhirang problema kung saan lumilitaw ang kaunting mesh; nararamdaman at naaayos.

MASAKIT BA? Ginagawa ito sa ilalim ng anesthesia (general o spinal), kaya wala kayong nararamdaman habang ginagawa ito, at karaniwang tumatagal ng wala pang 30 minuto. Karamihan sa pasyente ay **umuwi sa parehong araw** na may banayad na paninikip at mabilis na makabalik sa magaan na gawain.

Paano Maghanda

- Sundin ang inyong mga **tagubilin sa anesthesia** (pag-aayuno, pagtigil ng blood thinners ayon sa utos).
- Isang **pagsusuri ng ihi** para matiyak walang impeksiyon; minsan may bladder-function testing bago pa.
- Mag-ayos ng sasakyan pauwi; planuhing magpahinga ng ilang linggo para sa magaan na gawain.

Ano ang Nangyayari

- 1 Kayo ay natutulog o namamanhid; ibinibigay ang antibiotics.
- 2 Isang maliit na hiwa sa vagina ang ginagawa at ang tape ay inilalagay nang walang tensyon sa ilalim ng gitna ng urethra.
- 3 Ang maliliit na exit points (sa itaas ng pubic bone o sa singit) ay nagsasara nang kusa; ang hiwa sa vagina ay tinatahi.
- 4 Karaniwang umihi kayo bago umuwi upang matiyak na maayos ang paglalabas ng ihi.

Pagkatapos ng Operasyon

- Normal ang banayad na paninikip at kaunting pagdurugo.
- **Iwasan ang mabigat na pagbubuhat, pagpupumilit, at pakikipagtalik sa loob ng humigit-kumulang 6 na linggo.**
- Minsan kailangan ng catheter nang ilang araw kung mabagal ang pag-ihing simula.

Tawagan ang inyong care team kung kayo ay may:

- **Hindi kayo makaihi** o pakiramdam hindi kumpleto ang paglalabas ng ihi
- Lagnat, o mabigat na pagdurugo
- Lumalalang sakit, o sakit sa pakikipagtalik o vaginal discharge (maaaring may problema sa mesh)

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

1. Ang mid-urethral sling ay sumusuporta sa urethra para itigil ang pagtagas ng ihi sa diin — mabilis, outpatient, lubhang epektibo, at wala nang kailangang gawin pagkatapos.
2. Ang mesh nito ay lubos na pinag-aralan at kaiba sa na-recall na prolapse mesh; ang sariling tissue sling ay opsyon kung mas gusto ninyo.
3. Iwasan ang mabigat na pagbubuhat at pakikipagtalik ~6 linggo. Tumawag kung hindi kayo makaihi, magkalagnat, o magkaroon ng sakit/discharge.